

I.P.A.B. Luigi Mariutto

**Promuovere la Qualità della Vita Professionale
nelle professioni d'aiuto:
Il ruolo dell'Intelligenza Emotiva di Tratto**



Anno 2025

Promuovere la Qualità della Vita Professionale nelle professioni d'aiuto: Il ruolo dell'Intelligenza Emotiva di Tratto

Promoting Professional Quality of Life in healthcare professions: The role of Trait Emotional Intelligence

Autori: Vittorio Benvenuto, Angelomaria Alessio, Lamberto Peruzzo

Abstract

La presente ricerca indaga il ruolo dell'Intelligenza Emotiva di Tratto (TEI) nella qualità della vita professionale di Operatori Socio-Sanitari (OSS), Infermieri e altre figure assistenziali, con particolare attenzione alla Soddisfazione da Compassione (CS), al Burnout e allo Stress Traumatico Secondario (STS). Il campione, composto da 97 professionisti dell'I.P.A.B. Luigi Mariutto di Mirano (VE), è stato valutato attraverso il *Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Short Form* (TEIQue-SF) e la *Professional Quality of Life Scale - 5* (ProQol-5). I risultati mostrano che il Benessere e l'Emotività, due dimensioni della TEI, sono predittori positivi della CS, mentre il punteggio globale della TEI è un predittore negativo del Burnout, con un effetto significativamente maggiore per gli OSS rispetto agli Infermieri. Inoltre, il Benessere e l'Autocontrollo si rivelano fattori protettivi contro lo STS. Gli OSS e gli Infermieri, rispetto ad altre figure professionali, traggono maggiore gratificazione dalla propria professione d'aiuto e sono più vulnerabili allo STS, evidenziando la necessità di interventi mirati e programmi di formazione per migliorare la gestione emotiva, nonché ridurre il rischio di Burnout, promuovendo così il benessere lavorativo e prevenendo l'esaurimento emotivo. I risultati di questo studio mirano, pertanto, a contribuire al miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'ambiente professionale, con importanti benefici anche per gli ospiti dei contesti di cura come l'I.P.A.B. Luigi Mariutto.

Abstract

The present study investigates the role of Trait Emotional Intelligence (TEI) in the professional quality of life of Healthcare Assistants (OSS), Nurses, and other caregiving professionals, with particular attention to Compassion Satisfaction (CS), Burnout, and Secondary Traumatic Stress (STS). The sample, composed of 97 professionals from the I.P.A.B. Luigi Mariutto in Mirano (VE), was assessed through the *Trait Emotional Intelligence Questionnaire - Short Form* (TEIQue-SF) and the *Professional Quality of Life Scale - 5* (ProQol-5). The results show that Well-Being and Emotionality, two dimensions of TEI, are positive predictors of CS, while the global TEI score is a negative predictor of Burnout, with a significantly greater effect for OSS compared to Nurses. Furthermore, Well-Being and Self-Control prove to be protective factors against STS. OSS and Nurses, compared to other professional roles, derive greater gratification from their helping profession and are more vulnerable to STS, highlighting the need for targeted interventions and training programs to improve emotional management and reduce the risk of Burnout, thus promoting occupational well-being and preventing emotional exhaustion. The results of this study therefore aim to contribute to the improvement of the quality of care and the professional environment, with important benefits also for the residents of care settings such as the I.P.A.B. Luigi Mariutto.

1. INTRODUZIONE

1.1. *Qualità della Vita Professionale*

Con il termine *Qualità della Vita Professionale* ci si riferisce a un costrutto relativo a come le persone percepiscono la propria esperienza lavorativa nelle professioni d'aiuto, e si compone di due dimensioni principali. La prima è positiva, rappresentata dalla Soddisfazione da Compassione [CS – *Compassion Satisfaction*], mentre l'altra è negativa e si manifesta attraverso la Fatica da Compassione [CF – *Compassion Fatigue*]; quest'ultima si articola in due componenti: il Burnout e lo Stress Traumatico Secondario [STS – *Secondary Traumatic Stress*] (Stamm, 2010). Esempi di figure professionali che operano in contesti assistenziali e che, dunque, possono essere coinvolte in situazioni di crisi su scala individuale o sociale (sia essa comunitaria, nazionale o internazionale) sono gli Infermieri, gli Operatori Socio-Sanitari [OSS], i medici, gli psicologi, gli educatori, gli assistenti sociali, gli insegnanti, gli avvocati, gli agenti di polizia e le squadre di soccorso post-disastro (*ibidem*).

La CS riguarda il senso di appagamento che deriva dalla possibilità di svolgere il proprio lavoro in modo efficace. I professionisti che esperiscono elevati livelli di CS provano piacere nell'aiutare gli altri, si sentono motivati dal proprio ruolo e possono percepire positivamente l'ambiente lavorativo, i colleghi e il contributo che offrono alla società. Predittori della CS noti in letteratura sono le ricompense percepite, la sovrapponibilità dei valori individuali con quelli dell'organizzazione per cui si lavora, il capitale psicologico¹ e il carico di lavoro².

Il Burnout è definito come una condizione di esaurimento emotivo³, caratterizzata da depersonalizzazione e una ridotta soddisfazione lavorativa, che può esitare nell'abbandono dell'ambiente lavorativo (Maslach, 1996). Coloro che riportano alti livelli di Burnout possono esperire un senso di inefficacia in relazione alla propria attività professionale, la cui emersione è graduale e può essere aggravata da un eccessivo carico di lavoro, dall'attribuzione di troppe responsabilità o dalla mancanza di un supporto sufficientemente adeguato nell'ambiente di lavoro. Lo Stress Traumatico Secondario è definito come una reazione sul piano fisiologico e psicologico in risposta all'esposizione secondaria ad eventi traumatici (e.g.: leggere rapporti forensi con dettagli raccapriccianti; interrogatori). I principali sintomi sono il sentirsi intimoriti o irritabili, l'ipertensione,

¹ Capitale psicologico: risorsa individuale costituita da speranza, senso di efficacia, resilienza e ottimismo (Luthans et al. 2004).

² Carico di lavoro: insieme delle richieste fisiche ed emotive che è necessario soddisfare sotto la pressione temporale dei propri orari/turni di lavoro (Leiter & Maslach, 2003).

³ Esaurimento emotivo: caratteristica del Burnout che concerne la mancanza di energia durante la giornata lavorativa, sentimenti di vuoto ed esaurimento delle risorse emotive, nonché apatia e distaccamento nei confronti del lavoro (Maslach et al., 1996).

disturbi del sonno e intrusività dell'episodio traumatico (Kelty et al., 2023). I professionisti che lavorano a stretto contatto con individui che hanno subito traumi o grandi cambiamenti (come l'ingresso in residenze sanitarie assistenziali) possono sviluppare sintomi simili a quelli di un trauma diretto. È utile precisare che Figley (1995) fu colui che coniò il termine "Fatica da Compassione", mentre Pearlman & Mac Ian (1995) hanno parlato di Trauma Vicario e Stamm (1995) ha sviluppato il concetto di Stress Traumatico Secondario; nonostante diversi tentativi di tracciare chiari confini tra i concetti, non è emersa nessuna differenza nelle loro definizioni (Stamm, 2010).

Negli ultimi anni, le ricerche scientifiche di settore hanno dimostrato che un contesto lavorativo tipico delle professioni d'aiuto può offrire uno spazio in cui gli aspetti positivi del lavoro assistenziale sono interpretabili come un'espressione di altruismo; tuttavia l'esposizione (spesso ripetuta) a materiale traumatico può aggravarne gli effetti negativi, aumentando il rischio di sviluppare stress (che può esitare in *Burnout*), di avere significative deflessioni del tono dell'umore (che possono condurre allo sviluppo di una sindrome depressiva), di abusare di sostanze (da cui possono derivare ulteriori problemi, tra cui la dipendenza dalle sostanze di cui si fa uso), o di esperire sintomi analoghi a quelli del Disturbo da Stress Post-Traumatico [PTSD – *Post-Traumatic Stress Disorder*].

1.2. *Intelligenza Emotiva*

Il concetto di intelligenza emotiva affonda le sue radici nei primi decenni del secolo scorso, quando Thorndike (1920) descrisse la capacità di comprendere e gestire le proprie emozioni e quelle altrui al fine di adattarsi efficacemente all'ambiente. Tuttavia, il termine "Intelligenza Emotiva" [EI – *Emotional Intelligence*] venne introdotto ufficialmente solo da Leuner (1966), mentre Bar-On (1988) fu il primo a parlare di 'Quoziente Emotivo' in contesto scientifico. A partire dagli Anni '90, l'interesse verso l'EI ha iniziato a crescere notevolmente, portando alla formulazione di numerosi modelli teorici e definizioni.

Secondo Mayer et al. (2008) l'EI è concettualizzata come un insieme di abilità che consentono di riconoscere, interpretare ed elaborare le emozioni e le informazioni ad esse associate. Queste capacità, che variano da individuo a individuo, includono la consapevolezza e l'identificazione delle proprie emozioni, l'attenzione agli stati emotivi e la gestione strategica delle emozioni, ossia la capacità di modularle, trasformarle, regolarle o sopprimerle in funzione del contesto. Ad esempio, di fronte al lutto di una persona amica, la capacità di riconoscere e comprendere le proprie emozioni è una competenza fondamentale, così come lo è saper cogliere quelle dell'amico, tanto attraverso l'uso delle parole quanto mediante quello di gesti ed espressioni facciali. Comprendere lo stato emotivo

della persona che sta affrontando la perdita consente di adattare il proprio comportamento e modo di pensare alla situazione. Secondo Mayer (2004) una persona con un elevato livello di EI sarà in grado di offrire supporto e vicinanza all'amico, aiutandolo a elaborare il dolore e a superare il momento difficile.

La presente ricerca si fonda sulla significativa distinzione in due categorie teoriche dell'Intelligenza Emotiva proposta da Petrides & Furnham (2000; 2001), ovvero:

- Intelligenza Emotiva di Tratto [TEI - *Trait Emotional Intelligence*]: si riferisce a un insieme di caratteristiche disposizionali e autopercezioni emotive, strettamente legate alla personalità e misurate attraverso questionari *self-report*;
- Intelligenza Emotiva di Abilità [IPEI - *Information Processing Emotional Intelligence*]: riguarda la capacità di elaborare informazioni emotive in modo oggettivo ed è valutata mediante test di massima prestazione (*performance*), in cui esistono risposte corrette e sbagliate.

All'inizio del Millennio, alcuni ricercatori hanno sottolineato che il nome stesso dell'EI fosse ossimorico, e che potrebbe essere più opportuno etichettarla piuttosto come auto-efficacia emotiva (Petrides & Furnham, 2001; Petrides et al., 2007a), in quanto consente di incorporare anche le credenze dell'individuo in relazione alla propria intelligenza emotiva; ciononostante, non tutta la comunità scientifica è concorde con tale proposta, in quanto il costrutto dell'EI concerne anche elementi legati alla percezione del Sé e alla personalità che non hanno prettamente attinenza con l'auto-efficacia, come ad esempio bassi livelli di impulsività (Kirk et al., 2008).

La TEI è intesa come un insieme variegato di disposizioni che riguardano schemi abituali di comportamento, pensiero ed esperienza emotiva (Petrides, 2010). Queste disposizioni sono associate alla capacità di percepire, regolare, gestire ed esprimere informazioni di natura emotiva, oltre che a caratteristiche individuali come l'autocontrollo e la motivazione personale (Petrides, 2011). Con l'uso della locuzione "di Tratto" ci si riferisce al concetto di disposizione proposto da Eysenck & Eysenck (1985), sottolineando tanto la riconducibilità della TEI all'ampio dominio delle caratteristiche personologiche, quanto al fatto che essa non sia annoverabile tra le abilità cognitive. Il fatto che Petrides & Furnham (2001) abbiano deciso di mantenere "Intelligenza Emotiva" nel nome del costrutto da loro proposto è stato dettato dall'appropriatezza di vincolare la TEI alla Letteratura scientifica sull'EI.

Secondo i ricercatori che si sono occupati sinora di TEI, essa è da considerarsi una componente di basso livello della personalità di un individuo (Petrides et al. 2007b) piuttosto che un'abilità (Veselka et al., 2010). A riprova di ciò sono stati condotti studi di genetica comportamentale, dai quali

è emerso che l'entità del contributo genetico alla varianza fenotipica nella TEI si avvicina alle medesime stime di ereditabilità delle componenti di personalità di alto livello (Vernon et al., 2008). Risulta interessante constatare come strumenti *self-report* per l'*assessment* dell'EI non misurino effettivamente delle abilità, quanto piuttosto la percezione individuale circa esse; questo potrebbe voler dire che suddetti strumenti misurerebbero anche altre variabili, come i valori dell'individuo (Andrei, 2015).

Secondo il modello proposto da Petrides & Furnham (2000; 2001) vi sono quindici aree dell'Intelligenza Emotiva di Tratto. L'analisi fattoriale condotta per la realizzazione del *Trait Emotional Intelligence Questionnaire* [TEIQue], realizzata da Petrides (2009), ha consentito l'emersione di 4 dimensioni (i.e.: fattori) all'interno delle quali si collocano le anzidette aree. Si propone di seguito un approfondimento delle suddette dimensioni.

Benessere (*Well-being*): punteggi elevati in questo fattore riflettono un senso generalizzato di benessere, che si estende dai successi passati alle aspettative future. In generale, chi ottiene punteggi alti si sente positivo, felice e soddisfatto. Al contrario, punteggi bassi sono associati a una bassa autostima e a un senso di insoddisfazione rispetto alla propria vita attuale. In particolare sono state individuate 3 aree del Benessere: l'*Autostima*, intesa come valutazione complessiva di sé stessi (esempio di item: *Sento di avere molte buone qualità*); la *Felicità di tratto*, che concerne l'esperire appagamento e felicità per la propria esistenza (esempio di item: *Complessivamente sono contento della mia vita*); l'*Ottimismo di tratto*, che concerne il considerare il lato positivo della vita (esempio di item: *Generalmente credo che le cose mi andranno bene nella vita*).

Autocontrollo (*Self-control*): coloro che ottengono punteggi alti hanno un buon controllo sui propri impulsi e desideri. Oltre a saper gestire gli impulsi, riescono a regolare bene le pressioni esterne e lo stress; in altre parole, si tratta di individui che non risultano né repressivi né eccessivamente espressivi. Al contrario, chi ha punteggi bassi tende a comportamenti impulsivi e può avere difficoltà nella gestione dello stress. Le aree dell'Autocontrollo individuate sono state: la *Gestione dello stress*, intesa come capacità di sostenere la pressione e regolare lo stress (esempio di item: *Mi descriverei come una persona calma*); la *Regolazione delle emozioni*, ovvero la capacità di esercitare controllo sulle proprie emozioni (esempio di item: *Riesco a calmarmi facilmente dopo essermi spaventato*); l'*Impulsività (bassa)*, intesa come capacità di controllare i propri impulsi (esempio di item: *Controllare i miei impulsi non rappresenta un grande problema per me*).

Emotività (*Emotionality*): gli individui con punteggi elevati in questo fattore sono in sintonia con le proprie emozioni e con quelle degli altri. Riescono a percepire ed esprimere le emozioni e usano queste capacità per sviluppare e mantenere relazioni strette con le persone importanti. Al

contrario, coloro che ottengono punteggi bassi trovano difficile riconoscere i propri stati emotivi interni ed esprimere i loro sentimenti agli altri, il che può portare a relazioni personali meno gratificanti. A loro volta, le aree dell'Emotività sono: la *Percezione delle emozioni proprie e altrui*, intesa come capacità di percepire chiaramente le proprie e altrui emozioni (esempio di item: *Trovo spesso difficile riconoscere quale emozione sto provando*); l'*Espressione delle emozioni*, ovvero la capacità di comunicare le proprie emozioni alle altre persone (esempio di item: *Trovo difficile dire alle persone che le amo anche quando vorrei*); le *Abilità relazionali*, intese come capacità di stabilire e mantenere relazioni interpersonali soddisfacenti (esempio di item: *È molto importante per me andare d'accordo con tutti i miei amici stretti e la mia famiglia*); l'*Empatia di tratto*, capacità di assumere la prospettiva emotiva altrui (esempio di item: *Non è un problema per me comprendere i bisogni e i desideri degli altri*).

Socievolezza (*Sociability*): questo fattore si differenzia da quello dell'Emozionalità perché enfatizza le relazioni sociali e l'influenza sociale. L'attenzione è sull'individuo come attore nei contesti sociali, piuttosto che sulle relazioni personali con familiari e amici intimi. Chi ha punteggi alti è più abile nell'interazione sociale: sa ascoltare, comunicare in modo chiaro e sicuro con persone di diversi contesti. Al contrario, chi ottiene punteggi bassi si percepisce come incapace di influenzare le emozioni altrui, ha minori capacità di negoziazione e *networking*, ed è spesso incerto su cosa dire o fare nelle situazioni sociali, apparendo timido e riservato. Le aree della Socievolezza individuate sono: la *Gestione delle emozioni altrui*, intesa come capacità di produrre un cambiamento nelle emozioni altrui (esempio di item: *Se volessi sarebbe facile per me far arrabbiare qualcuno*); l'*Assertività*, ovvero la capacità di esprimere pensieri ed opinioni tenendo in considerazione il punto di vista altrui, al fine di evitare l'insorgenza di atteggiamenti aggressivi, verbali e non verbali (esempio di item: *Quando non sono d'accordo con qualcuno, di solito trovo facile dirlo*); la *Competenza sociale*: capacità di far uso delle abilità sociali all'interno della propria rete (esempio di item: *Riesco a interagire in maniera efficace con gli altri*).

Infine, vi sono due aree che non si collocano all'interno di nessun fattore, ovvero l'*Adattabilità*, intesa come capacità di adattarsi in modo flessibile a situazioni nuove (esempio di item: *Generalmente sono in grado di adattarmi a situazioni nuove*), e l'*Automotivazione* (i.e.: motivazione intrinseca), ovvero la capacità di motivare e direzionare sé stessi, nonché capacità di far fronte a eventi avversi (esempio di item: *Ho molti motivi per non arrendermi con facilità*).

1.3. Verso una comprensione del fenomeno

Tesi (2021) ha condotto uno studio con un campione di 302 professionisti che operavano in strutture sanitarie (e.g.: infermieri; educatori) al fine di comprendere l'impatto della TEI sulla qualità della vita professionale, concettualizzata in termini di Burnout (misurato con il *Maslach Burnout Inventory*) e di Coinvolgimento Lavorativo⁴ (*Work Engagement*, misurato con la *Utrecht Work Engagement Scale*): ad elevati punteggi di TEI si associano bassi livelli di *Burnout* e alti punteggi nel Coinvolgimento. Il ricercatore ha anche impiegato il modello *Job Demands-Resources* [JD-R, Bakker & Demerouti, 2007], secondo il quale vi sono due fondamentali categorie a determinare il benessere lavorativo. La prima riguarda le richieste lavorative (*job demands*), ovvero gli elementi fisici, psicologici, sociali e organizzativi del lavoro che richiedono sforzo e possono condurre all'insorgenza di stress (i.e.: pressione temporale; carico di lavoro elevato). La seconda categoria concerne le risorse lavorative (*job resources*), ovvero tutto ciò che nel contesto professionale aiuta il lavoratore a raggiungere gli obiettivi, a ridurre le richieste lavorative e ad accrescere la propria motivazione (i.e.: supporto sociale; feedback). Secondo il modello, le richieste eccessive possono contribuire ad un processo stressogeno che può esitare nello sviluppo del *Burnout*, mentre le risorse lavorative possono favorire il Coinvolgimento Lavorativo e l'efficienza della prestazione professionale. Tesi (2021) ha rilevato che le richieste lavorative emotive hanno un'associazione negativa con la TEI e positiva con il *Burnout*, mentre per le risorse lavorative legate alle relazioni tra colleghi esiste una relazione positiva con la TEI e con il Coinvolgimento Lavorativo. L'autore ha anche rilevato effetti indiretti significativi della TEI tanto sul *Burnout* grazie alla mediazione operata dalle richieste lavorative, quanto sul Coinvolgimento Lavorativo. I risultati sopra menzionati hanno corroborato quanto già emerso in altri studi, ovvero che per gli operatori nelle professioni di cura con elevati punteggi di TEI si rilevano punteggi inferiori nella CF (Amir et al., 2019; Barrera-Algarín, 2024), con particolare riferimento allo STS per medici e infermieri (Filipponi et al., 2022).

Infine, Tesi (2021) ha deciso di considerare anche le ore lavorate a settimana da ciascun partecipante alla ricerca, in quanto precedenti studi hanno rilevato come questo parametro possa considerarsi un predittore significativo della Fatica da Compassione (Khan et al., 2016).

2. LA RICERCA

2.1 Obiettivi

⁴ Coinvolgimento Lavorativo: condizione positiva e gratificante lavoro-correlata, caratterizzata da vigore (*vigor*: livello di energia e resilienza), dedizione (*dedication*) e profondo interesse (*absorption*: livello di importanza, entusiasmo, orgoglio, sfida e ispirazione) (Schaufeli et al., 2002).

L'obiettivo della ricerca in questione concerneva anzitutto la conferma di quanto emerso sinora in letteratura in merito alla TEI come predittore della *Qualità della Vita Professionale*, nonché sondare eventuali differenze nei livelli di CF dovute allo specifico ruolo professionale ricoperto e al numero di ore lavorate a settimana (scelto come parametro rappresentativo del carico di lavoro, e non come sua misura). Interagire con gli ospiti di una residenza per anziani è un aspetto condiviso da tutti i dipendenti che vi lavorano, sebbene i compiti associati ad ogni singolo ruolo siano differenti: un assistente sociale, ad esempio, ha un contatto con il singolo ospite che riguarda aspetti che travalicano i confini della residenza, coinvolgendo anche altre figure assistenziali del territorio e i familiari dei residenti; un fisioterapista, invece, può avere un contatto diretto maggiormente regolare e centrato sulla persona, ma condizionato dal possesso da parte dell'ospite dei requisiti psico-fisici necessari a partecipare alle attività riabilitative. Gli OSS e gli Infermieri si configurano come quelle figure professionali che spendono la maggior parte del loro tempo a contatto diretto con i pazienti, avendo a che fare anche con loro aspetti individuali a cui le altre figure professionali non hanno accesso (e.g.: vestizione; igiene personale; primo soccorso).

Le variabili dipendenti erano, dunque, il *Burnout*, lo Stress Traumatico Secondario e la Soddisfazione da Compassione. Le ore lavorate a settimana sono state misurate come variabile continua (poi centrata per le analisi successive), mentre il ruolo professionale ricoperto, variabile categoriale a tre livelli (i.e.: OSS; Infermieri; Altro), è stato gestito impostando contrasti di tipo Helmert. Come si approfondirà in seguito, le analisi sono state svolte secondo un approccio *data driven*, sulla base del quale sono state formulate quattro ipotesi con approccio NHST⁵, ovvero:

- $H_{0(1)}$: non vi sono differenze statisticamente significative nei livelli di Soddisfazione da Compassione prodotte da una delle dimensioni dell'Intelligenza Emotiva di Tratto o dal ruolo professionale ricoperto (confrontando prima OSS con Infermieri, e poi Altro con OSS+Infermieri);

$H_{1(1)}$: almeno uno dei predittori tra le dimensioni dell'Intelligenza Emotiva di Tratto o il ruolo professionale ricoperto produce un effetto statisticamente significativo sui livelli di Soddisfazione da Compassione.

⁵ Approccio NHST (*Null Hypothesis Significance Testing*) o “frequentista”: dato un campione di x osservazioni, è possibile calcolare una determinata statistica test, ad esempio t di Student; conoscendo la distribuzione campionaria di t sotto l'ipotesi H_0 (ovvero assumendo che l'ipotesi nulla sia vera), è possibile determinare la probabilità (chiamata *p-value*) di ottenere nuovamente quello stesso valore della statistica test, o uno più estremo (Cohen, 1994).

- $H_{0(2)}$: non vi sono differenze statisticamente significative nei livelli di Burnout prodotte dal punteggio complessivo di Intelligenza Emotiva di Tratto, dal ruolo professionale ricoperto (confrontando prima OSS con Infermieri, e poi Altro con OSS+Infermieri) o dall'interazione del ruolo professionale con l'Intelligenza Emotiva di Tratto;

$H_{1(2)}$: almeno uno dei predittori tra il punteggio complessivo di Intelligenza Emotiva di Tratto, il ruolo professionale ricoperto, o una la loro interazione produce un effetto statisticamente significativo sui livelli di Burnout.

- $H_{0(3)}$: non vi sono differenze statisticamente significative nei livelli di Stress Traumatico Secondario prodotte da una delle dimensioni dell'Intelligenza Emotiva di Tratto o dal ruolo professionale ricoperto (confrontando prima OSS con Infermieri, e poi Altro con OSS+Infermieri);

$H_{1(3)}$: almeno uno dei predittori tra le dimensioni dell'Intelligenza Emotiva di Tratto o il ruolo professionale ricoperto produce un effetto statisticamente significativo sui livelli di Stress Traumatico Secondario.

2.2 Metodi

2.2.1. Partecipanti

Per questa ricerca sono stati reclutati centouno soggetti tra il personale dell'I.P.A.B. Luigi Mariutto di Mirano (VE), quattro dei quali sono stati esclusi dalle successive analisi in quanto i loro punteggi per le variabili dipendenti superavano le 2.5 deviazioni standard rispetto alla media. Il campione finale era, dunque, costituito da 97 partecipanti ($N_{OSS} = 64$; $N_{Infermiere} = 9$; $N_{Altro} = 24$), di cui 75 donne, ed era rappresentativo della composizione del personale attivo. L'età media del campione era di 48.75 anni ($SD = 9.88$ anni). Le principali statistiche descrittive e i range di punteggio per ciascuna variabile sono riportati nella Tabella 1. Il disegno di ricerca era tra i soggetti (*between subjects*) e prevedeva la compilazione di un questionario in formato cartaceo o attraverso una pagina Google Form ad esso identica.

		Età	CS	Burnout	STS	TEI	Benessere	Autocontrollo	Emotività	Socievolezza
media		48.75	50.54	49.59	50.13	5.18	5.63	4.99	5.30	4.49
deviazione standard		9.88	8.81	9.81	9.35	0.75	1.06	0.98	0.88	0.97
mediana		51.00	49.66	49.20	49.69	5.23	5.83	5.00	5.38	4.50
errore standard medio		1.06	0.89	1.00	0.95	0.08	0.11	0.10	0.09	0.10
punteggio minimo (min.)		20	27.12	30.60	34.88	3.00	2.67	3.00	2.75	1.50
punteggio massimo (max.)		62	64.59	80.21	73.75	6.80	7.00	7.00	7.00	7.00
	min. (OSS)	22	27.12	30.60	34.88	3.47	2.67	3.00	2.75	1.50
	max. (OSS)	62	64.59	80.21	73.75	6.80	7.00	7.00	7.00	7.00
	min. (Infermieri)	33	46.65	40.93	45.99	3.00	2.83	3.00	4.25	1.50
	max. (Infermieri)	61	64.59	55.40	70.04	6.00	7.00	6.33	6.62	5.83
	min. (Altro)	20	31.62	36.80	36.73	4.20	4.50	3.00	4.25	3.00
	max. (Altro)	57	64.59	61.61	60.79	6.23	7.00	6.83	6.38	6.33

Tabella 1. La tabella mostra le principali statistiche descrittive per le variabili età, Soddisfazione da Compassione (CS), Burnout, Stress Traumatico Secondario (STS), punteggio complessivo al TEIQue-SF (TEI), Benessere, Autocontrollo, Emotività e Socievolezza. Nella parte inferiore della tabella sono riportati i range di punteggio per tutte le variabili menzionate.

2.2.2. Strumenti

Il questionario per la raccolta dati era diviso in tre sezioni, che verranno di seguito approfondite. La prima sezione era relativa alle informazioni socio-demografiche, e comprendeva dati come l'età, il numero di ore lavorate alla settimana e il proprio ruolo professionale.

Nella seconda sezione è stata proposta la versione italiana in forma breve del *Trait Emotional Intelligence Questionnaire* [TEIQue-SF] (Petrides, 2009). Questo strumento si compone di 30 item che indagano le quattro dimensioni della TEI (i.e.: Benessere; Autocontrollo, Emotività e Socievolezza), come ad esempio “*Molte volte non riesco a capire che emozione sto provando*”, a cui è possibile rispondere attraverso una scala Likert da 1 (*Completamente in disaccordo*) a 7 (*Completamente d'accordo*) per ottenere sia un punteggio globale di TEI, sia un punteggio per ciascuna delle sue dimensioni.

Infine, nella terza sezione è stata proposta la *Professional Quality of Life Scale - 5* (ProQol-5), un questionario self-report che consente l'*assessment* di CS e CF attraverso risposte su una scala Likert da 1 (*Mai*) a 5 (*Molto spesso*). In particolare, gli item per la CF sono 20, di cui dieci per il *Burnout* (e.g.: “*Sono la persona che ho sempre voluto essere*”) e dieci per lo STS (e.g.: “*Penso di essere stato influenzato dalle esperienze traumatiche delle persone che aiuto*”), mentre i restanti 10 misurano la CS sono (e.g.: “*Ho più energia dopo aver lavorato con coloro che aiuto*”). Il ProQol restituisce un punteggio per la CS, uno per il *Burnout* e uno per lo STS (non è presente un punteggio complessivo per la CF). I punteggi possono essere discretizzati in *basso* (< 22), *medio* ($23 \leq \text{punteggio} \leq 41$) e *alto* ($\text{punteggio} > 42$), per ciascuna delle scale (Stamm, 2010).

2.3 Risultati

Tutte le analisi sono state condotte mediante il software R.

2.3.1. Analisi correlazionale

L'analisi di correlazione ha mostrato delle associazioni tra i punteggi della TEI (complessivo e singole sottoscale) con CS e CF. In particolare, per il *Burnout* sono emerse correlazioni negative forti, statisticamente significative con il punteggio complessivo della TEI ($r = -0.69, p < .001$), con il Benessere ($r = -0.66, p < .001$), con l'Autocontrollo ($r = -0.54, p < .001$) e con l'Emotività ($r = -0.54, p < .001$), mentre è risultata esserci una correlazione media con la Socievolezza ($r = -0.43, p < .001$). Per quanto riguarda lo Stress Traumatico Secondario sono emerse correlazioni negative forti con il punteggio complessivo della TEI ($r = -0.51, p < .001$) e con l'Autocontrollo ($r = -0.51, p < .001$), mentre sono risultate esserci correlazioni negative medie statisticamente significative con il

Benessere ($r = -0.44, p < .001$) con l'Emotività ($r = -0.32, p < .001$) e con la Socievolezza ($r = -0.24$). Per quanto riguarda la CS, invece, sono emerse correlazioni positive medie con il punteggio complessivo della TEI ($r = 0.40, p < .001$) e con il Benessere ($r = 0.36, p < .001$), l'Emotività ($r = 0.44, p < .001$) e la Socievolezza ($r = 0.26, p < .001$), mentre non è emersa alcuna correlazione statisticamente significativa tra la CS e l'Autocontrollo. Il numero di ore lavorate a settimana non è risultato essere correlato con le altre variabili in modo statisticamente significativo, pertanto si è deciso di escludere questa variabile dalle analisi di regressione successive. Tutti i coefficienti di correlazione sono riportati nelle Figure 1 e 2.

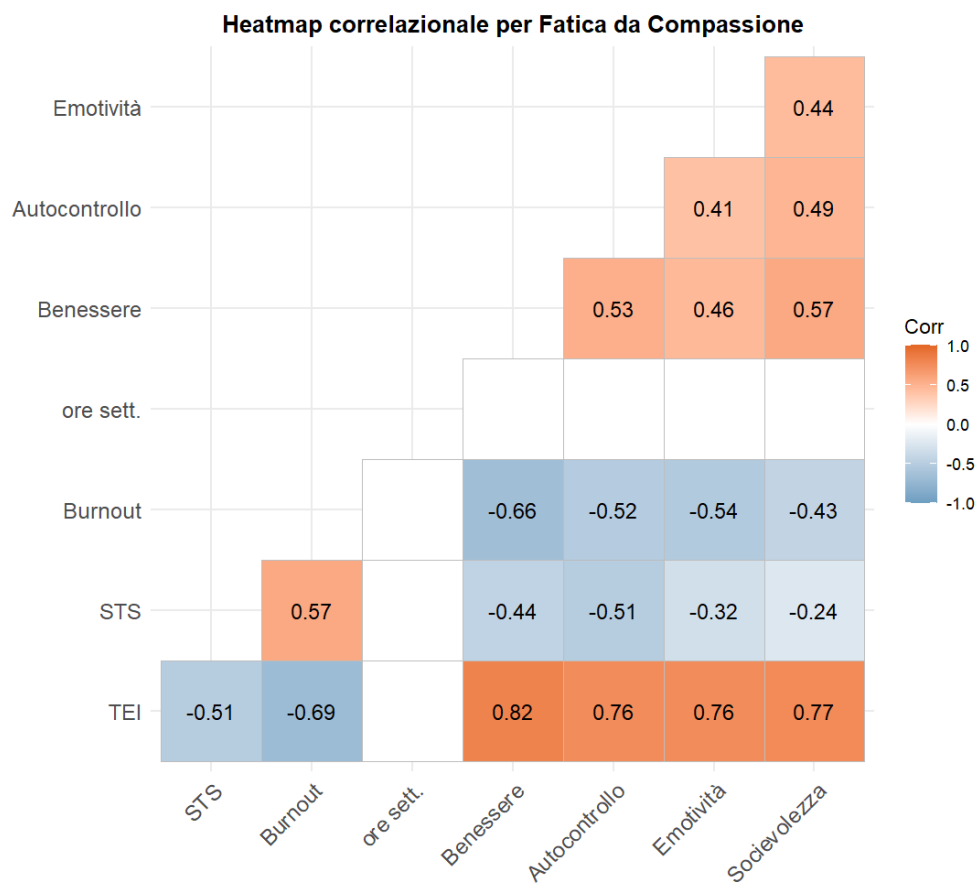


Figura 1. La figura mostra i coefficienti di correlazione tra il punteggio complessivo dell'Intelligenza Emotiva di Tratto (TEI), le sue dimensioni (Benessere, Autocontrollo, Emotività e Socievolezza), lo Stress Traumatico Secondario (STS), il Burnout e le ore lavorate a settimana. Sono riportati solo i coefficienti con $p\text{-value} > .05$.

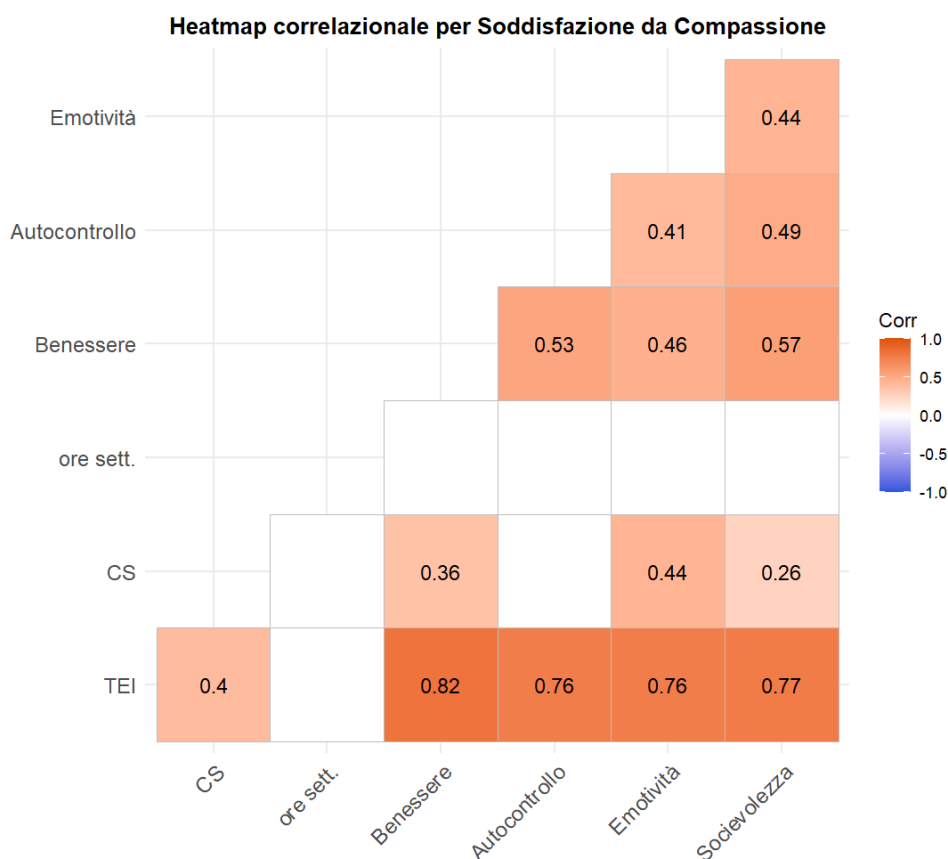


Figura 2. La figura mostra i coefficienti di correlazione tra il punteggio complessivo dell'Intelligenza Emotiva di Tratto (TEI), le sue dimensioni (Benessere, Autocontrollo, Emotività e Socievolezza), la Soddisfazione da Compassione (CS) e le ore lavorate a settimana. Sono riportati solo i coefficienti con $p\text{-value} > .05$.

2.3.2. Analisi preliminari

Le analisi condotte prima dello svolgimento delle regressioni hanno riguardato la verifica della collinearità tra i predittori, mediante il calcolo del *Generalized Variance Inflation Factor*⁶ [GVIF], la quale ha consentito di escludere la presenza di collinearità tra le variabili (vd. Tabelle 2, 3 e 4).

⁶ Il GVIF rappresenta il rapporto quadratico tra il volume dell'ellissoide di confidenza congiunto per un sottoinsieme di coefficienti e il volume dell'ellissoide che si otterrebbe se i predittori di quel sottoinsieme non fossero correlati con quelli del sottoinsieme complementare. Nel caso di un singolo coefficiente, il GVIF coincide con il VIF tradizionale; tuttavia, al fine di rendere i GVIF confrontabili tra sottoinsiemi di diversa dimensione, si utilizza $GVIF^{\frac{1}{2+df}}$, dove df è il numero di coefficienti nel sottoinsieme considerato. Questa trasformazione riporta il GVIF a una scala lineare e, quando $df = 1$, corrisponde all'aumento proporzionale dell'ampiezza dell'intervallo di confidenza dovuto alla collinearità (Fox & Monette, 1992).

Predittori per Soddisfazione da Compassione	GVIF	df	$GVIF^{\frac{1}{2 \cdot df}}$
Benessere	1.80	1	1.34
Autocontrollo	1.56	1	1.25
Emotività	1.40	1	1.18
Socievolezza	1.71	1	1.31
Ruolo professionale	1.06	2	1.02

Tabella 2. La tabella riporta i risultati dell'analisi di collinearità per il modello con Soddisfazione da Compassione come variabile dipendente.

Predittori per Burnout	GVIF	df	$GVIF^{\frac{1}{2 \cdot df}}$
Punteggio complessivo TEI	1	5	1
Ruolo professionale	1	5	1

Tabella 3. La tabella riporta i risultati dell'analisi di collinearità per il modello con Burnout come variabile dipendente.

Predittori per Stress Traumatico Secondario	GVIF	df	$GVIF^{\frac{1}{2 \cdot df}}$
Benessere	1.80	1	1.35
Autocontrollo	1.56	1	1.25
Emotività	1.40	1	1.19
Socievolezza	1.71	1	1.31
Ruolo professionale	1.86	2	1.03

Tabella 4. La tabella riporta i risultati dell'analisi di collinearità per il modello con Stress Traumatico Secondario come variabile dipendente.

Successivamente è stata condotto un test di Shapiro-Wilk al fine di verificare la normalità della distribuzione dei residui: l'assunto risulta rispettato sia per la Soddisfazione da Compassione ($w = 0.98$; $p > .05$), che per il Burnout ($w = 0.99$; $p > .05$) e per lo Stress Traumatico Secondario ($w = 0.99$; $p > .05$).

Per quanto riguarda le regressioni lineari, l'approccio adottato per ciascuna delle analisi è stato di tipo *data driven*, attraverso l'impiego dell'Akaike Information Criterion [AIC], da cui sono emersi i seguenti modelli con minor AIC (ovvero quelli indicativi del miglior compromesso tra bontà di adattamento ai dati e complessità):

H₀₍₁₎ [AIC: 680.34]

Soddisfazione da Compassione ~ Benessere + Autocontrollo + Emotività + Socievolezza + Ruolo

H₀₍₂₎ [AIC: 652.46]

Burnout ~ score complessivo TEI * Ruolo

H₀₍₃₎ [AIC: 673.83]

Stress Traumatico Secondario ~ Benessere + Autocontrollo + Emotività + Socievolezza + Ruolo

Per quanto riguarda la CS, il modello impiegato è in grado di cogliere un effetto statisticamente significativo di almeno uno dei predittori ($F_{(6,90)} = 7.33, p < .001, R_{adj}^2 = .28$). In particolare, come possibile apprezzare in Figura 3, le dimensioni della TEI che possono produrre un effetto sulla CS sono il Benessere ($\beta = 2.11, t_{(90)} = 2.07, p < .05$) e l'Emotività ($\beta = 3.54, t_{(90)} = 3.93, p < .001$): all'aumentare dei punteggi in una di queste scale è possibile aspettarsi un aumento del punteggio di Soddisfazione da Compassione, con un effetto maggiormente marcato per quanto riguarda l'Emotività. Non sono risultati statisticamente significativi gli altri predittori continui. È inoltre emerso l'effetto statisticamente significativo del Ruolo professionale ricoperto sulla CS, quando si confrontano i lavoratori del gruppo Altro con quelli dei gruppi OSS e Infermieri considerati insieme ($\beta = -2.27, t_{(90)} = -3.33, p < .01$), ad indicare che questi ultimi sono coloro che possono trarre un maggiore appagamento dalle attività svolte nella propria professione d'aiuto, rispetto alle altre figure professionali che operano nella medesima struttura (vd. Figura 4). Non sono emerse differenze statisticamente significative nei livelli di CS tra OSS e Infermieri, ad indicare che la soddisfazione di cui possono giovare è simile.

Per quanto concerne il Burnout, il modello impiegato è in grado di cogliere un effetto statisticamente significativo di almeno uno dei predittori ($F_{(5,91)} = 22.78, p < .001, R_{adj}^2 = .53$). In particolare, per quanto riguarda gli effetti principali è emerso che il punteggio globale della TEI possa produrre un effetto significativo sul Burnout ($\beta = -6.08, t_{(91)} = -4.42, p < .001$), tale per cui all'aumentare del punteggio complessivo di TEI è possibile aspettarsi un calo dei punteggi di Burnout (vd. Figura 5); inoltre, è emersa una differenza statisticamente significativa nei livelli di Burnout tra Infermieri e OSS ($\beta = -29.16, t_{(91)} = -3.90, p < .001$), ma non tra il gruppo Altro e i gruppi OSS e Infermieri considerati insieme (vd. Figura 6). Per quanto riguarda gli effetti di interazione, come

mostrato nella Figura 7, è risultato statisticamente significativo l'effetto del punteggio globale della TEI in funzione del Ruolo professionale ricoperto: all'aumentare dei punteggi di Intelligenza Emotiva di Tratto è possibile aspettarsi un calo dei livelli di Burnout più marcato per gli OSS rispetto agli Infermieri ($\beta = 5.46, t_{(91)} = 3.90, p < .001$); non è emersa un'interazione significativa tra TEI e Ruolo professionale ricoperto, quando si confrontano i lavoratori del gruppo Altro con i lavoratori dei gruppi OSS e Infermieri considerati insieme.

Per quanto riguarda lo Stress Traumatico Secondario, il modello impiegato è in grado di cogliere un effetto statisticamente significativo di almeno uno dei predittori ($F_{(6,90)} = 8.50, p < .001, R_{adj}^2 = .32$). In particolare, come mostrato in Figura 8, le dimensioni della TEI che possono produrre un effetto sullo STS sono il Benessere ($\beta = -2.60, t_{(90)} = -2.47, p < .05$) e l'Autocontrollo ($\beta = -3.95, t_{(90)} = 4.01, p < .001$): all'aumentare dei punteggi in una di queste scale è possibile aspettarsi un calo del punteggio sulla scala dello Stress Traumatico Secondario, con un effetto più marcato per quanto riguarda l'Autocontrollo. Non sono risultati statisticamente significativi gli altri predittori continui. È inoltre emerso l'effetto statisticamente significativo del Ruolo professionale ricoperto sullo STS, quando si confrontano i lavoratori del gruppo Altro con quelli dei gruppi OSS e Infermieri considerati insieme ($\beta = -1.65, t_{(90)} = -2.34, p < .01$), ad indicare che questi ultimi sono coloro che possono beneficiare maggiormente delle proprie risorse di Intelligenza Emotiva di Tratto come fattori di protezione dallo sviluppo dello STS derivante dalle attività svolte nella propria professione d'aiuto, rispetto alle altre figure professionali che operano nella medesima struttura (vd. Figura 9). Non sono emerse differenze statisticamente significative nei livelli di STS tra OSS e Infermieri, ad indicare che il beneficio che possono trarre è simile.

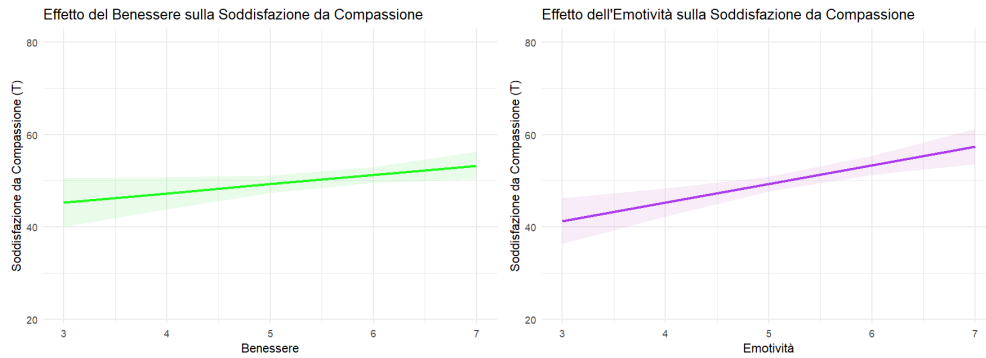


Figura 3. La figura mostra gli effetti significativi di Benessere (a sinistra) ed Emotività (a destra) sulla Soddisfazione da Compassione (con $\alpha = 0.05$).

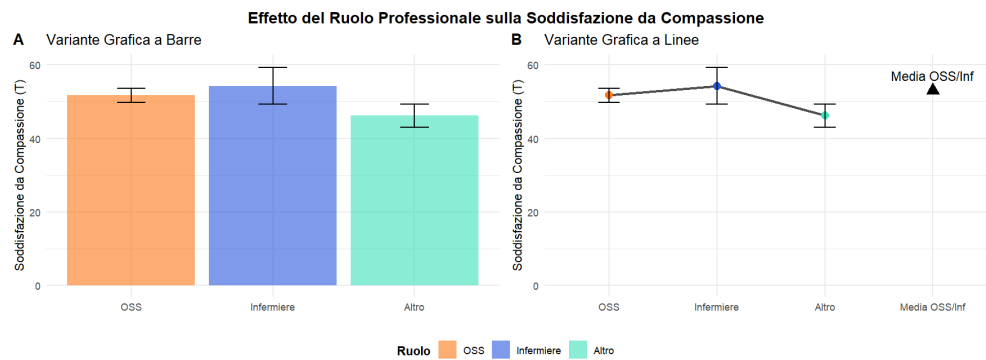


Figura 4. La figura mostra l'effetto del Ruolo professionale ricoperto sulla Soddisfazione da Compassione (con $\alpha = 0.05$) in due varianti: grafico a barre (a sinistra) e grafico a linee (a destra), nel quale è riportato il punteggio medio di Soddisfazione da Compassione di OSS e Infermieri considerati insieme (Media OSS/Inf).

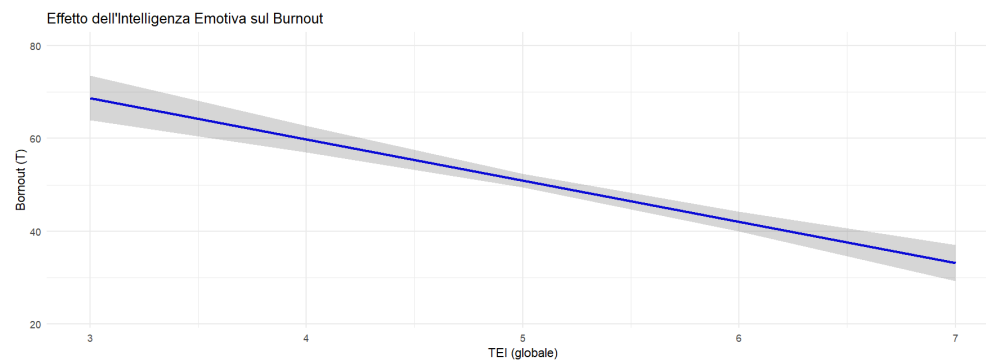


Figura 5. La figura mostra l'effetto dell'Intelligenza Emotiva di Tratto (punteggio globale) sui livelli di Burnout (con $\alpha = 0.05$).

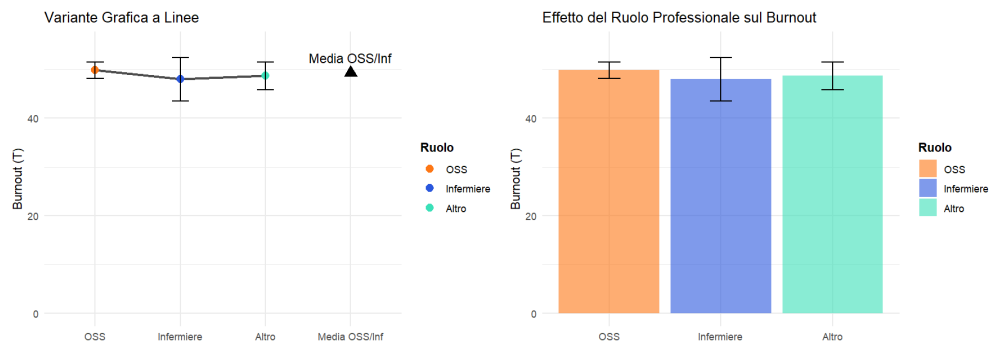


Figura 6. La figura mostra l'effetto del Ruolo professionale ricoperto sul Burnout (con $\alpha = 0.05$) in due varianti: grafico a barre (a sinistra) e grafico a linee (a destra), nel quale è riportato il punteggio medio di Burnout di OSS e Infermieri considerati insieme (Media OSS/Inf).

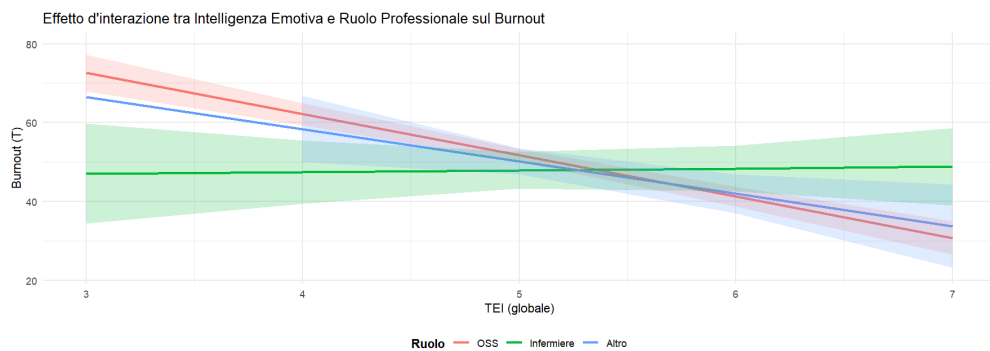


Figura 7. La figura mostra l'effetto di interazione tra il Ruolo professionale ricoperto e l'Intelligenza Emotiva di Tratto (punteggio globale) sul Burnout (con $\alpha = 0.05$).

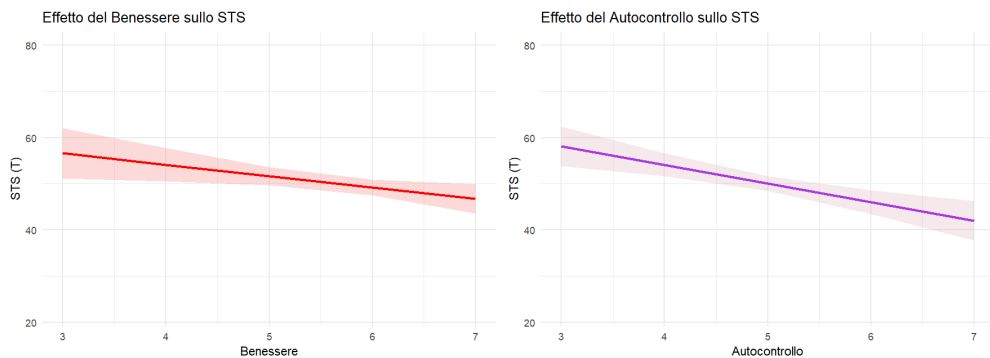


Figura 8. La figura mostra gli effetti significativi di Benessere (a sinistra) e Autocontrollo (a destra) sullo Stress Traumatico Secondario (con $\alpha = 0.05$).

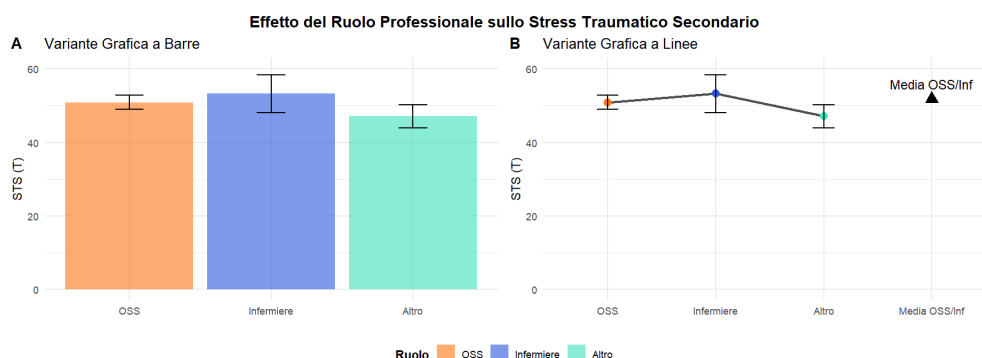


Figura 9. La figura mostra l'effetto del Ruolo professionale ricoperto sullo Stress Traumatico Secondario (con $\alpha = 0.05$) in due varianti: grafico a barre (a sinistra) e grafico a linee (a destra), nel quale è riportato il punteggio medio di Stress Traumatico Secondario di OSS e Infermieri considerati insieme (Media OSS/Inf).

2.4 Discussione

La presente ricerca ha consentito anzitutto di mettere in relazione rilevazioni effettuate mediante l'uso combinato del TEIQue-SF e del ProQol-5 in un contesto di cura, l'I.P.A.B. Luigi Mariutto di Mirano (VE), con quelle di studi precedenti che hanno misurato i medesimi costrutti con altri strumenti (Tesi, 2021). L'unico precedente che ha impiegato i suddetti strumenti, e del quale abbiamo trovato traccia, è lo studio di Filipponi e colleghi (2022), nel quale tuttavia i ricercatori hanno usato come variabile dipendente solamente il punteggio medio degli item relativi allo STS come misura della Fatica da Compassione.

I risultati della presente ricerca hanno mostrato che, nei contesti professionali di cura, un buon equilibrio emotivo e la capacità di riconoscere, gestire e comunicare le emozioni (proprie e altrui) contribuiscono ad esperire una maggiore soddisfazione nel lavoro di aiuto, in particolare per coloro che lavorano a stretto contatto con i pazienti come OSS e Infermieri. Quest'ultimo dato, tuttavia, non indica che i lavoratori con ruoli non direttamente coinvolti nell'assistenza ai residenti traggano meno gratificazione dal proprio lavoro in senso assoluto, ma che la specificità dell'assistenza alla persona non consenta loro di raggiungere gli stessi livelli di gratificazione di OSS e Infermieri. In definitiva, il Benessere (componente di positività generale) e l'Emotività (componente empatica) rappresentano il cuore della gratificazione nelle professioni di cura.

Dalle analisi è emerso come il punteggio globale della TEI sia un predittore negativo del Burnout. In particolare, gli Infermieri hanno riportato punteggi di Burnout significativamente inferiori rispetto a quelli degli OSS, e questo dato è in apparente controtendenza con altre ricerche che hanno mostrato come gli Infermieri siano maggiormente esposti degli OSS allo sviluppo del Burnout a causa dell'esaurimento emotivo (Marques et al., 2021), anche se è fondamentale precisare

che questi studi sono stati condotti in contesti ospedalieri (e.g.: reparti di oncologia), i quali hanno caratteristiche molto differenti rispetto a un contesto residenziale per anziani. Pertanto, una corretta interpretazione dei risultati richiede una duplice riflessione, di seguito approfondita.

Anzitutto, come è possibile apprezzare nella Tabella 1, la variabilità complessiva dei punteggi di Burnout va da 30.60 a 80.21, ed equivale alla variabilità dei punteggi per gli OSS, mentre gli Infermieri riportano punteggi in un range da 40.93 a 55.40 e i lavoratori del gruppo Altro da 31.62 a 64.59. I punteggi degli Infermieri si collocano tutti, dunque, molto vicini ai valori centrali della scala, pertanto non solo non sorprende che vi sia una differenza statisticamente significativa nei punteggi di Burnout tra OSS e Infermieri, ma non stupisce nemmeno che non emerga alcuna differenza tra i lavoratori del gruppo Altro quando confrontati con OSS e Infermieri considerati insieme. Una seconda riflessione a proposito di questi risultati potrebbe essere legata al fatto che gli Infermieri, rispetto agli OSS, potrebbero disporre di maggiori risorse per fronteggiare il Burnout (e.g.: aver frequentato corsi di formazione del personale sul tema), oppure potrebbero esserci dei fattori ruolo-specifici in grado di influenzare il livello di Burnout per gli OSS ma non per gli Infermieri. Inoltre, è possibile che gli Infermieri dell'I.P.A.B. Luigi Mariutto siano poco esposti a fattori di rischio il cui impatto sullo sviluppo del Burnout è già stato ampiamente dimostrato, come ad esempio elevate richieste lavorative, incremento delle responsabilità sul lavoro, mancanza di supporto organizzativo (HaGani et al., 2022).

L'interazione tra Ruolo professionale ricoperto e punteggio complessivo della TEI nel determinare il livello di Burnout è risultata essere statisticamente significativa, suggerendo che l'effetto protettivo della TEI è più forte negli OSS rispetto agli Infermieri. Questo dato potrebbe indicare che, negli OSS, un'alta TEI aiuti a mitigare più efficacemente lo sviluppo del Burnout; ciò risulta maggiormente rilevante se si osservano i range di punteggio alla sottoscala del Burnout (vd. Tabella 1), sulla base dei quali è possibile affermare che gli OSS sono i lavoratori maggiormente esposti allo sviluppo del Burnout rispetto agli altri.

Per quanto concerne lo STS è emerso come il Benessere e l'Autocontrollo ne siano fattori protettivi; in particolare, l'Autocontrollo mostra un effetto molto più forte del Benessere, ad indicare che abilità quali la regolazione degli impulsi e la gestione efficace dello stress riducono significativamente i sintomi di STS. Pertanto è possibile affermare che chi padroneggia queste strategie sia meno soggetto a pensieri intrusivi e *iperarousal*. Inoltre, i livelli di STS per OSS e Infermieri sono sovrapponibili, a differenza di quelli dei lavoratori del gruppo Altro, che risultano inferiori; ciò suggerisce che OSS e Infermieri siano più vulnerabili allo STS, probabilmente per la

maggiore frequenza di contatto con pazienti in condizioni critiche o per l'impatto empatico di esperienze traumatiche indirette.

3. CONCLUSIONI

Lavorare a contatto con persone che presentano patologie croniche (psicologiche e/o organiche), difficoltà nell'elaborazione socio-cognitiva degli stimoli presenti nel loro ambiente e, in aggiunta, un basso (o assente) livello di autonomia nella cura di sé, accompagnato dalla necessità di assistenza sanitaria clinica costante, potrebbe facilmente esporre i professionisti ad esperienze stress e, col tempo, a sviluppare Burnout. La presente ricerca consente di affermare che l'Intelligenza Emotiva di Tratto sia un costrutto rilevante nel fronteggiare le succitate minacce al mantenimento di una buona qualità della vita professionale, specialmente in funzione del ruolo ricoperto nell'organizzazione.

Inoltre, come suggerito da numerosi studi, vi sono anche altri fattori protettivi nei confronti dello sviluppo del Burnout, quali la resilienza, la cura di sé e l'equilibrio casa-lavoro (Murali et al. 2018; Vetter et al., 2018); pertanto potrebbe essere utile includere queste variabili in future ricerche che si propongono di meglio comprendere il differente impatto sui livelli di Burnout di diversi lavoratori che operano nello stesso ambiente lavorativo di assistenza alla persona e che hanno a che fare con i medesimi utenti/pazienti. Per quanto concerne l'altro lato della medaglia, l'Intelligenza Emotiva di Tratto è anche un fattore di promozione del Coinvolgimento Lavorativo (Tesi, 2022) e, pertanto, risulta una risorsa utile anche per incrementare la gratificazione che deriva dallo svolgimento della propria attività professionale.

È inoltre importante sottolineare come, secondo la Teoria del Ruolo di Genere⁷ le donne tendano ad affrontare lo stress attraverso l'espressione e la condivisione delle proprie emozioni (Eagly, 2013), comportando una maggiore probabilità di sviluppare esaurimento emotivo (Purvanova & Muros, 2013), il quale può essere più facilmente fronteggiato da coloro che riportano alti livelli di TEI (Tesi, 2022). Data l'elevata prevalenza di donne nel campione del presente studio (i.e.: 77.32%), potrebbe essere consigliabile in futuro impiegare anche questionari in grado di misurare le dimensioni del Burnout in un disegno di ricerca che consideri il bilanciamento del campione in base al genere; tale accortezza potrebbe essere utile per cogliere se la TEI sia in grado di produrre effetti differenti sui livelli di Burnout in funzione del ruolo sociale attribuito al proprio genere di appartenenza.

⁷ Secondo la Teoria del Ruolo di Genere (*Gender Role Theory*) uomini e donne apprendono e interiorizzano comportamenti, atteggiamenti e norme sociali differenti sulla base delle aspettative culturali associate al proprio sesso biologico. La percezione di sé e il comportamento individuale sono influenzati da suddette aspettative culturali, e ciò comporta una differenziazione nella socializzazione fin dall'infanzia (Eagly, 2013).

Come dimostrato da Nellis et al. (2009), è possibile incrementare la propria Intelligenza Emotiva partecipando ad interventi di formazione strutturati, basati sul modello a quattro rami di Mayer & Salovey⁸, che prevedono insegnamenti teorici, *role-playing*, esercitazioni pratiche (a coppie o in gruppo) e l'uso di un diario emotivo. Con soli quattro incontri della durata di 150 minuti è possibile ottenere miglioramenti significativi nella regolazione delle proprie emozioni (misurata con ERP-Q), nella gestione di quelle altrui (rilevata con EMA) e nella riduzione dei livelli di alessitimia (misurati con TAS-20); tali effetti perdurano a distanza di 6 mesi dall'intervento e non dipendono dai livelli iniziali di Intelligenza Emotiva dei partecipanti, a suggerirne una generalizzabilità trasversale. I miglioramenti che ne possono derivare sono tanto a livello individuale (come evidenziato dalla presente ricerca osservando i livelli di Soddisfazione da Compassione, Burnout e Stress Traumatico Secondario in relazione ai punteggi di Intelligenza Emotiva di Tratto), quanto a livello interpersonale, favorendo pertanto il miglioramento delle condizioni dell'ambiente lavorativo. Interventi di formazione dell'Intelligenza Emotiva possono dunque ridurre l'assenteismo, accrescere la resilienza e prevenire il Burnout (Schutte et al., 2007), nonché accresce la capacità di operare più efficacemente con colleghi e pazienti, favorendo una comunicazione assertiva e prevenendo l'accumulo di tensioni interpersonali.

⁸ Il modello di Mayer & Salovey concerne quattro elementi: 1) percezione, valutazione ed espressione delle emozioni; 2) facilitazione emotiva del pensiero; 3) comprensione ed analisi delle emozioni; 4) regolazione riflessiva delle emozioni.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

- Amir, K. (2019). Emotional intelligence as predictor of compassion fatigue among mental health practitioners. *Open Access Library Journal*, 6(05), 1. <https://doi.org/10.4236/oalib.1105410>
- Andrei, F. (2015). *Trait emotional intelligence: Evidence from italian adolescents and adults* [Tesi di Dottorato, Alma Mater Studiorum Università di Bologna]. <https://doi.org/10.6092/unibo/amsdottorato/6898>
- Bakker, A. B., & Demerouti, E. (2007). The job demands-resources model: State of the art. *Journal of Managerial Psychology*, 22(3), 309-328. <https://doi.org/10.1108/02683940710733115>
- Bar-On, R. (1988). *The development of a concept of psychological well-being*. Makhanda: Rhodes University Press.
- Barrera-Algarín, E., Castro-Ibáñez, R., Vallejo-Andrada, A., & Martínez-Fernández, R. (2024). Compassion fatigue syndrome in social workers and its relationship with emotional intelligence. *Social Work*, 69(1), 26-34. <https://doi.org/10.1093/sw/swad038>
- Cohen, J. (1994). The earth is round ($p < .05$). *American Psychologist*, 49(12), 997–1003. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.49.12.997>
- Eagly, A. H. (2013). *Sex differences in social behavior: A social-role interpretation*. New York (NY): Psychology Press. <https://doi.org/10.4324/9780203781906>
- Eysenck, H.J. & Eysenck, M.W. (1985) *Personality and individual differences. A natural science approach*. New York (NY): Springer.
- Filipponi, C., Pizzoli, S. F., Masiero, M., Cutica, I., & Pravettoni, G. (2022). The partial mediator role of satisficing decision-making style between trait emotional intelligence and compassion fatigue in healthcare professionals. *Psychological Reports*, 127(2), 868-886. <http://dx.doi.org/10.1177/00332941221129127>
- Figley, C. R. (1995). Compassion fatigue: Toward a new understanding of the costs of caring. In B. H. Stamm (Ed.), *Secondary traumatic stress: Self-care issues for clinicians, researchers, and educators* (pp. 3–28). The Sidran Press.
- Fox, J., & Monette, G. (1992). Generalized Collinearity Diagnostics. *Journal of the American Statistical Association*, 87(417), 178–183. <https://doi.org/10.1080/01621459.1992.10475190>
- HaGani, N., Yagil, D., & Cohen, M. (2022). Burnout among oncologists and oncology nurses: A systematic review and meta-analysis. *Health Psychology*, 41(1), 53. <https://doi.org/10.1037/hea0001155>
- Kelty, S., Green, N., Ribaux, O., Roux, C., & Robertson, J. (2023). Assessment of occupational stress. In M. M. Houck (Ed.), *Encyclopedia of Forensic Sciences, Third Edition, 1*, 209-220. Amsterdam: Elsevier. <https://doi.org/10.1016/b978-0-12-823677-2.00017-9>

- Khan, A. A., Khan, M. A., & Bokhari, S. A. (2016). Association of specialty and working hours with compassion fatigue: Working hours and compassion fatigue. *Pakistan Armed Forces Medical Journal*, 66(1), 143-46. <https://pafmj.org/index.php/PAFMJ/article/view/418>
- Kirk, B. A., Schutte, N. S., & Hine, D. W. (2008). Development and preliminary validation of an emotional self-efficacy scale. *Personality and Individual Differences*, 45, 432–436. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2008.06.010>
- Leiter, M. P., & Maslach, C. (2003). Areas of worklife: A structured approach to organizational predictors of job burnout. In *Emotional and physiological processes and positive intervention strategies*, 3, (pp. 91-134). Leeds: Emerald Group Publishing Limited.
- Leuner B. (1966). Emotionale intelligenz und emanzipation. Eine psychodynamische studie über die frau [Emotional intelligence and emancipation. A psychodynamic study on women]. *Praxis der Kinderpsychologie und Kinderpsychiatrie*, 15(6), 196–203.
- Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. *Business Horizons*, 47(1), 45–50. <https://doi.org/10.1016/j.bushor.2003.11.007>
- Marques, M. M., Alves, E., Queirós, C., Norton, P., & Henriques, A. (2018). The effect of profession on burnout in hospital staff. *Occupational Medicine*, 68(3), 207-210. <https://doi.org/10.1093/occmed/kqy039>
- Maslach, C. (1996). Burnout: A multidimensional perspective, in W. B. Schaufeli, C. Maslach, & T. Marek (Eds.), *Professional Burnout: Recent Developments in Theory and Research* (pp. 19-32). Washington (D.C.): Taylor & Francis. <https://doi.org/10.1201/9780203741825>
- Mayer, J. D. (2004). "What is Emotional Intelligence?" *University of New Hampshire - Personality Lab* 8. https://scholars.unh.edu/personality_lab/8 [13.03.2025]
- Mayer, J. D., Salovey, P., & Caruso, D. R. (2008). Emotional intelligence: New ability or eclectic traits? *American Psychologist*, 63(6), 503–517. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.63.6.503>
- Murali, K., Makker, V., Lynch, J., & Banerjee, S. (2018). From burnout to resilience: An update for oncologists. *American Society of Clinical Oncology Educational Book*, 38, 862–872. https://doi.org/10.1200/EDBK_201023
- Nelis, D., Quoidbach, J., Mikolajczak, M., & Hansenne, M. (2009). Increasing emotional intelligence: (How) is it possible?. *Personality and individual differences*, 47(1), 36-41. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2009.01.046>
- Pearlman, L. A., & Mac Ian, P. S. (1995). Vicarious traumatization: An empirical study of the effects of trauma work on trauma therapists. *Professional Psychology: Research and Practice*, 26(6), 558-565.
- Petrides, K. V. (2009). Psychometric properties of the trait emotional intelligence questionnaire (TEIQue). In C. Stough, D. H. Saklofske & J. D. A. Parker (Eds.), *Assessing emotional intelligence: Theory, research, and applications* (pp. 85-101). New York (NY): Springer.

<https://doi.org/10.1007/978-0-387-88370-0>

- Petrides, K. V. (2010). Trait emotional intelligence theory. *Industrial and Organizational Psychology*, 3, 136–139. <https://doi.org/10.1111/j.1754-9434.2010.01213.x>
- Petrides, K. V. (2011). Ability and trait emotional intelligence. In T. Chamorro-Premuzic, S. von Stumm & A. Furnham (Cur.), *The Wiley-Blackwell handbook of individual differences*, 656–678. Hoboken (NJ): John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781444343120>
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2000). On the dimensional structure of emotional intelligence. *Personality and Individual Differences*, 29(2), 313–320. [https://doi.org/10.1016/S0191-8869\(99\)00195-6](https://doi.org/10.1016/S0191-8869(99)00195-6)
- Petrides, K. V., & Furnham, A. (2001). Trait emotional intelligence: Psychometric investigation with reference to established trait taxonomies. *European Journal of Personality*, 15, 425–448. <https://doi.org/10.1002/per.416>
- Petrides, K. V., Pérez-González, J. C., & Furnham, A. (2007a). On the criterion and incremental validity of trait emotional intelligence. *Cognition & Emotion*, 21, 26–55. <https://doi.org/10.1080/02699930601038912>
- Petrides, K. V., Pita, R., & Kokkinaki, F. (2007b). The location of trait emotional intelligence in personality factor space. *British Journal of Psychology*, 98, 273–289. <https://doi.org/10.1348/000712606X120618>
- Purvanova, R. K., & Muros, J. P. (2010). Gender differences in burnout: A meta-analysis. *Journal of Vocational Behavior*, 77(2), 168–185. <https://doi.org/10.1016/j.jvb.2010.04.006>
- Schaufeli, W. B., Salanova, M., González-Romá, V., & Bakker, A. B. (2002). The measurement of engagement and burnout: A two sample confirmatory factor analytic approach. *Journal of Happiness Studies*, 3, 71–92. <https://doi.org/10.1023/A:1015630930326>
- Schutte, N. S., Malouff, J. M., Thorsteinsson, E. B., Bhullar, N., & Rooke, S. E. (2007). A meta-analytic investigation of the relationship between emotional intelligence and health. *Personality and Individual Differences*, 42, 921–933. <https://doi.org/10.1016/j.paid.2006.09.003>
- Stamm, B. H. (1995). *Professional Quality of Life Scale (PROQOL)* [Database record]. APA PsycTests. <https://doi.org/10.1037/t05192-000>
- Stamm, B.H. (2010). *The Concise ProQOL Manual*. ProQOL.org. <https://tinyurl.com/ProQol-Manual-2010>
- Tesi, A. (2021). A dual path model of work-related well-being in healthcare and social work settings: The interweaving between trait emotional intelligence, end-user job demands, coworkers related job resources, burnout, and work engagement. *Frontiers in Psychology*, 12, 660035. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2021.660035>
- Thorndike, E. L. (1920). Intelligence and its uses. *Harper's Magazine*, 140, 227–235.

- Vernon, P. A., Petrides, K. V., Bratko, D., & Schermer, J. A. (2008). A behavioral genetic study of trait emotional intelligence. *Emotion*, 8, 635–642. <https://doi.org/10.1037/a0013439>
- Veselka, L., Petrides, K. V., Schermer, J. A., Cherkas, L. F., Spector, T. D., & Vernon, P. A. (2010). Phenotypic and genetic relations between the HEXACO dimensions and trait emotional intelligence. *Twin Research and Human Genetics*, 13, 66–71. <https://doi.org/10.1375/twin.13.1.66>
- Vetter, M. H., Vetter, M. K., & Fowler, J. (2018). Resilience, hope and flourishing are inversely associated with burnout among members of the Society for Gynecologic Oncology. *Gynecologic Oncology Reports*, 25, 52–55. <https://doi.org/10.1016/j.gore.2018.06.002>